

De complete gids voor betere slaap na 40

Alles wat je moet weten over slaaphygiëne, gerichte supplementen en ritme-opbouw — in één overzichtelijke PDF.

- ▣ Waarom magnesiumglycinaat voor veel mensen handiger is dan oxide voor slaap
- ▣ Een 7-dagenprotocol dat je direct kunt proberen — mét 'niet doen'-lijsten per fase
- ▣ Doseringen in perspectief: magnesium, ashwagandha, melatonine en L-theanine
- ▣ Veelgemaakte fouten die je slaap ondermijnen zonder dat je het merkt

Slaap is het fundament waar stress en herstel op bouwen. Zorg eerst voor ritme en rust om je heen — supplementen zijn hooguit een gerichte aanvulling als dat basisplaatje klopt.

— PerfectSupplement — redactioneel uitgangspunt

Inhoudsopgave

- | | |
|----|--|
| 01 | Waarom je slaap verandert na 40 |
| 02 | De 5 grootste slaapfouten (+ een veel voorkomende zesde) |
| 03 | Het 7-dagen slaapritme-protocol |
| 04 | Supplementen in perspectief |
| 05 | Doseringen en veiligheid (globaal kader) |
| 06 | Week-voor-week actieplan |
| 07 | Veelgestelde vragen |

01 Waarom je slaap verandert na 40

Na je 40e merk je vaak drie dingen in je slaap. Dit hoeft niets te zeggen over je karakter — het is gewoon biologie. Snap je wat er schuift, dan kun je gerichter kiezen wat je wél aanpast.

Je maakt minder melatonine aan — geleidelijk

Melatonine is het hormoon dat je lichaam vertelt: nu wordt het tijd om rust te nemen (donker helpt die aanmaak op gang). Onderzoek suggereert dat je eigen aanmaak na je 30e en 40e stap voor stap kan dalen¹². Ook op latere leeftijd zie je lagere nachtwaarden dan bij jonge volwassenen — **hoe sterk dat verschilt, verschilt per mens**³. In de praktijk voelt dat als minder makkelijk 'intrappen' en wat lichter slapen.

Je diepe slaap kan relatief korter worden

Je slaap loopt in rondjes met lichte slaap, diepe slaap en droomslaap (REM). **Diepe slaap** is het deel waarin je lichaam echt herstelt: spieren bijtrekken, geheugen opslaan, immuunsysteem opladen. Studies laten zien dat zo'n diepe fase met de jaren minder lang kan zijn — ook als je nog even lang in bed ligt⁴. Je wordt dan sneller wakker en staat minder fris op.

Je stresshormoon kan 's avonds te hoog blijven hangen

Cortisol is je belangrijkste stresshormoon. 's Avonds hoort het te zakken, zodat je systeem naar rust kan schakelen. Bij langdurige spanning blijft het soms te hoog — dan sta je nog 'aan' terwijl je eigenlijk wilt slapen. Dat kan samenhangen met herstel en hormonen — maar het legt geen diagnose bij jou vast⁵. Je voelt je dan vaak moe én gespannen tegelijk.

Het klassieke patroon

In slaap vallen lukt nog, maar rond 03:00 lig je wakker met een bonzend hart en een hoofd dat maar doorjaagt. Dan kan het zijn dat je lichaam te vroeg schakelt alsof het ochtend is — terwijl het midden in de nacht is. Zoek eerst rust en ritme overdag; alleen harder je best doen in bed lost dat zelden op.

Slaap en testosteron horen bij elkaar

Onderzoek laat zien dat een groot deel van je dagelijkse testosteron in spanning staat met slaap — vooral met **diepe slaap**. Als vuistregel wordt wel genoemd dat een flink deel (vaak in de buurt van **70–80%**) samenhangt met slaap en slaapkwaliteit — maar het is **geen vast recept voor elk individu**⁶. Het punt voor jou: als diepe slaap blijft teruglopen, wordt zo'n keten kwetsbaarder. Dit is geen medische oordeel — alleen een reden om slaap serieus te nemen.

Bronnen

- ¹ Wurtman RJ. Age-Related Decreases in Melatonin Secretion—Clinical Consequences. *J Clin Endocrinol Metab.* 2000;85(6):2135–2136. PMID: 10852443
- ² Hardeland R. Melatonin in Aging and Disease—Multiple Consequences of Reduced Secretion, Options and Limits of Treatment. *Aging Dis.* 2012;3(2):194–225. PMC3377831
- ³ Claustat B, Leston J. Melatonin: Physiological effects in humans. *Neurochirurgie.* 2015;61(2–3):77–84.
- ⁴ Ohayon MM et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals. *Sleep.* 2004;27(7):1255–1273. PMID: 15586779
- ⁵ Leproult R, Van Cauter E. Effect of 1 week of sleep restriction on testosterone levels in young healthy men. *JAMA.* 2011;305(21):2173–2174. PMID: 21632481
- ⁶ Wittert G. The relationship between sleep disorders and testosterone in men. *Asian J Androl.* 2014;16(2):262–265. PMC3955336

02 De 5 grootste slaapfouten (+ een veel voorkomende zesde)

Veel mannen van midden veertig herkennen dezelfde valkuilen — niet omdat ze lui zijn, maar omdat wat op je dertigste nog werkte, op je veertigste harder tegenaan tikt.

Fout 1: Cafeïne laat op de dag

Na ongeveer **5–6 uur** zit nog de helft van de cafeïne in je bloed⁷. Koffie om 15:00 kan 's avonds dus nog merkbaar spelen. **Hetzelfde geldt voor sterke groene thee en energy drinks** — niet alleen espresso.

Fout 2: Scherm tot aan bed

Helder licht — vooral het schermlicht waar veel blauw in zit — **remt 's avonds je aanmaak van melatonine**. Dat is het hormoon dat je lichaam vertelt dat het bedtijd wordt⁸. Leg je telefoon minimaal 45–60 minuten voor slapen ergens waar je niet grijpjes naar wordt.

Fout 3: Willekeurige bedtijden

Je **biologische klok** houdt niet van sociale jetlag. Streef ernaar om ook in het weekend binnen ongeveer hetzelfde halfuur uit bed te komen.

Fout 4: Te laat zwaar sporten

Zware training laat je lichaam nog lang opspelden. Plan zo'n blok liever eerder op de dag; een rustige wandeling 's avonds kan juist helpen om spanning kwijt te raken.

Fout 5: Een slaapkamer die te warm is — en alleen maar aan het klimaat denken

Voor veel mensen is een slaapkamer van **ongeveer 16–18 °C** gunstig voor inslapen⁹. Thermoregulatie gaat ook over timing: **90 minuten voor bed een warme douche** gevolgd door afkoeling kan inslapen helpen door een duidelijke daling van kerntemperatuur daarna.

Fout 6: Te lang in bed liggen terwijl je niet slaapt

Als je vaak wakker ligt, noemen ze dat een **lage slaapefficiëntie**: een groot deel van je tijd in bed is wakker tijd. **7 uur in bed met 6,5 uur slapen** voelt dan vaak beter dan **9 uur in bed met dezelfde 6,5 uur slapen**. Je wilt niet dat je brein bed koppelt aan piekeren. Sta op, zoek rust zonder scherm, en ga pas terug als je weer moe wordt.

Bronnen

⁷ Drake C et al. Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. J Clin Sleep Med. 2013;9(11):1195–1200. PMC3805807

⁸ Chang AM et al. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep. Proc Natl Acad Sci USA. 2015;112(4):1232–1237. PMID: 25535358

- ⁹ Okamoto-Mizuno K, Mizuno K. Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm. *J Physiol Anthropol.* 2012;31(1):14. PMC3427038

03 Het 7-dagen slaapritme-protocol

Dit bouwt stap voor stap — je hoeft niet perfect te zijn. Ga voor een paar vaste gewoontes die je wél volhoudt.

Dag 1–2: Basis

- Vaste opstaantijd (ook weekend)
- Cafeïne niet na lunch
- Slaapkamer koeler en donkerder maken

Niet doen (fase 1)

Geen 'compensatie-siesta' van 90 minuten midden op de dag; geen laat avondmaal met veel alcohol 'om te ontspannen'.

Dag 3–4: Avondafsluiting

- Schermen weg vanaf 45–60 min voor slapen
- Eenvoudig ritueel: lezen, stretch, ademhaling
- Geen alcohol als slaapmiddel — niet 'even een glas' om sneller weg te zijn

Niet doen (fase 2)

Geen zware discussies of werk-mail vlak voor bed; geen scherm in bed 'nog één video'.

Dag 5–6: Daglicht en lichte beweging

- **Binnen 30 minuten na opstaan even naar buiten** — daglicht helpt je biologische klok op tijd te zetten¹⁰
- Rustige wandeling na diner om spanning af te bouwen

Niet doen (fase 3)

Geen zeer zware intervaltraining of maximale kracht sessie na 20:00 als je merkt dat je daarna nog te lang 'opgewonden' blijft.

Dag 7: Check

Noteer in één minuut: inslaaptijd, nachtelijke wakker periodes, ochtendfrisheid (1–10). Dat is je baseline voor de volgende weken.

Niet doen (fase 4)

Geen dramatische 'alles-of-niets' correctie op dag 7 — kies maximaal één extra stap voor week 2.

Tip: Overweeg vanaf dag 3 magnesiumglycinaat als onderdeel van je avondroutine (zie hoofdstuk 5 voor dosering).

Bronnen

¹⁰ Blume C et al. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. *Somnologie*. 2019;23(3):147–156. PMC6751071

04 Supplementen in perspectief

Supplementen vullen niets aan als ritme, licht, temperatuur en stress niet eerder aan bod zijn. Als dat basisplaatje klopt, kunnen ze soms een gerichte extra zijn.

Magnesium — waar veel mensen mee beginnen

Magnesium hoort bij **een van de meest onderzochte mineralen** rond slaap en spanning — maar uitkomsten verschillen per persoon. Bij magnesiumglycinaat/bisglycinaat melden sommige proeven betere **ingeschatte slaapkwaliteit**¹¹; bredere reviews zien wisselende maar vaak bescheiden effecten¹². Het kan een rol spelen bij ontspanning van spieren en een rustiger gevoel — dat betekent **geen harde belofte** voor elke lezer.

Vorm	Opname / gebruik	Slaap-context
Glycinaat / bisglycinaat	Meestal goed verdragen	Veel gekozen in een avondroutine
Citraat	Kan het toilet-op zoeken	Soms gekozen om andere redenen
Oxide	Wordt minder goed opgenomen	Meestal geen eerste keus voor slaap
L-theanine (uit thee)	Voelt voor velen niet als 'chemisch suf'	Vaak 100–200 mg voor slapen; uitkomst verschilt per persoon
Ashwagandha (bijv. KSM-66)	Langere horizon nodig	Sommigen gebruiken het bij stress en slaap

Kort gezegd: kies bij slaap meestal **glycinaat of bisglycinaat**. Oxide levert vaak minder waar voor je geld. De andere rijen zijn opties als ze bij jou passen.

Het aminozuur **glycine** — onderdeel van glycinaatverbindingen — wordt in onderzoek in verband gebracht met een kalmerend effect en slaapkwaliteit¹³.

Ashwagandha — vooral als spanning je slaap saboteert

Sommige extracten (zoals KSM-66) zijn getest in gecontroleerde studies: daar rapporteerden **deelnemers soms lagere stresscores en gunstigere stresshormoonprofielen** ten opzichte van een placebo — maar niet iedereen merkt het even sterk¹⁴¹⁵. Bij gestandaardiseerde extracten staat op het etiket een vast percentage werkzame stoffen (withanoliden) — zo weet je dat een capsule niet steeds anders sterk is.

Belangrijk over ashwagandha

Ashwagandha heeft geen door de EFSA goedgekeurde gezondheidsclaims. Wat je hier leest steunt op onderzoek bij vrijwilligers — niet op zo'n officiële claim. In Nederland loopt discussie over regels voor dit kruid; blijf kritisch op merken en labels.

Melatonine — soms handig, niet voor iedereen voor altijd

Een heel kleine dosis kan soms helpen bij ritme-shifts; langdurig elke dag gebruiken zonder dat een arts meedenkt, is zelden nodig¹⁶.

L-theanine — rust zonder meteen 'weg te zijn'

L-theanine komt uit thee. Sommige studies suggereren dat het kan bijdragen aan meer rust zonder zware sedatie — maar je eigen gevoel telt. Veel mensen starten rond **200 mg**, 30–60 minuten voor slapen; bouw liever rustig op.

Stapelen vs. niet stapelen

Begin met één supplement. Voeg pas na minimaal **2 weken** een tweede toe als je basis al aanvoelt alsof die klopt. Zo weet je wat bijdraagt — en wat alleen kosten en complexiteit toevoegt.

Bronnen

¹¹ Schuster J et al. Magnesium Bisglycinate Supplementation in Healthy Adults Reporting Poor Sleep: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. *Nat Sci Sleep*. 2025;17. PMC12412596

¹² Rawji A et al. Examining the Effects of Supplemental Magnesium on Self-Reported Anxiety and Sleep Quality: A Systematic Review. *Cureus*. 2024;16(4):e59317. PMC11136869

¹³ Bannai M, Kawai N. New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep. *J Pharmacol Sci*. 2012;118(2):145–148. PMID: 22293292

¹⁴ Lopresti AL et al. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Medicine*. 2019;98(37):e17186. PMC6979308

¹⁵ Chandrasekhar K et al. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. *Indian J Psychol Med*. 2012;34(3):255–262. PMID: 23439798

¹⁶ Auld F et al. Evidence for the efficacy of melatonin in the treatment of primary adult sleep disorders. *Sleep Med Rev*. 2017;34:10–22. PMID: 28648359

05 Doseringen en veiligheid (globaal kader)

Dit zijn **geen voorschriften**, maar gangbare vensters uit onderzoek en praktijk. Gebruik je medicatie, ben je ziek, zwanger of geef je borstvoeding? Bespreek altijd even met je huisarts voordat je begint.

Magnesium (glycinaat/bisglycinaat)

- ▢ Veel gebruik: **200–400 mg elementair magnesium** — dat is het deel dat je lichaam echt meetelt; staat zo op het etiket. Neem het 30–60 min voor slapen. Grotere magnesium-inname wordt in bevolkingsonderzoek geassocieerd met slaapduur en -kwaliteit — maar correlatie is geen garantie voor jou¹⁷
- ▢ Begin bij een lagere dosis als je maag daar gevoelig voor is
- ▢ Raadpleeg je huisarts als je medicatie gebruikt

Interacties / let-op

Magnesium kan de opname van sommige antibiotica verminderen (zoals quinolonen en tetracyclines). Houd minimaal **2 uur** tussen pil en magnesium. Zelfde idee vaak voor schildklierpillen en bisfosfonaten.

Ashwagandha (KSM-66 voorbeeld)

- ▢ Veel gebruik: 300 mg, 2× per dag bij eten — evalueer na 4–6 weken (zie onderzoekscontext¹⁴¹⁵)
- ▢ Raadpleeg je huisarts als je medicatie gebruikt

Interacties / let-op

Let extra op bij schildklierklachten of kalmerende medicatie. Stop bij klachten aan je maag en overleg. Gebruik je medicatie? Neem dit altijd even langs je arts.

Melatonine

- ▢ Veel microdosering: 0,3–0,5 mg, 30–60 min voor slapen
- ▢ Korte periodes proberen en evalueren — niet maandenlang zelf ophogen
- ▢ Raadpleeg je huisarts als je medicatie gebruikt

Interacties / let-op

Let op bij bloedverdunners en immunosuppressiva — melatonine wordt niet altijd verdragen door iedereen; overleg bij twijfel.

L-theanine

- ▣ Avond: vaak 100–200 mg voor slapen
- ▣ Overdag kleiner proberen bij spanning — als het bij jou past
- ▣ Raadpleeg je huisarts als je medicatie gebruikt

Interacties / let-op

Overweg voorzichtig bij gebruik van bloeddrukmedicatie of stimulantia — bespreek bij combinaties met cafeïne als je gevoelig bent voor bloeddruk.

Bronnen

- ¹⁷ Zhang Y et al. Association of magnesium intake with sleep duration and sleep quality. PLoS One. 2022;17(1):e0261989. PMC8782427

06 Week-voor-week actieplan

Week 1: Quick wins

- Koele, donkere slaapkamer
- Schermen weg voor bed
- Vaste opstaantijd
- Cafeïne niet na lunch

Week 2–4: Ritme verdiepen

- Avondwandeling na diner
- Magnesiumglycinaat routinematig (zie hoofdstuk 5)
- Alcohol beperken en niet als slaapmiddel
- Alcohol niet vlak voor slapen — minimale 'relax' is een vals signaal voor je brein

Week 5–8: Verdieping

Nu gaat het niet om 'nog meer regels', maar om stabiliteit en meetbare verbetering. Kies één extra scherp punt — bijvoorbeeld consistent daglicht binnen een vast venster, of een vaste 'shutdown' van werk om 20:00.

- Mini-**slaapdagboek** vier keer per week — kort genoteerd is genoeg om patronen te zien¹⁸
- Optioneel ashwagandha alleen als spanning nog het hoofdthema is — **geen EFSA-goedgekeurde claims**; eerst je arts raadplegen bij medicatie
- Evalueer supplementkeuzes met startdatum — wat heeft geholpen, wat niet?

Meet je baseline — dan pas optimaliseren

Gebruik de gratis Leefstijlcheck om je uitgangspunt vast te leggen vóór je grote wijzigingen doorvoert en **herhaal na ±4 weken**. Zo voorkom je dat je blind stapelt zonder te weten wat werkte.

Bronnen

¹⁸ Carney CE et al. The consensus sleep diary: standardizing prospective self-monitoring. Sleep. 2012;35(2):287–302. PMC3250369

07 Veelgestelde vragen

Kan ik magnesium combineren met ashwagandha?

Ja, veel mensen combineren ze — maar niet alle pillen tegelijk in één slok als je maag daar gevoelig voor is. Begin liever met één middel; voeg na een paar weken pas een tweede toe zodat je bijwerkingen kunt herleiden. **Ashwagandha heeft geen EFSA-goedgekeurde claims;** overleg bij medicatie.

Hoe lang moet ik supplementen gebruiken?

Ashwagandha wil je vaak pas na een paar weken opnieuw bekijken; magnesium kan voor sommige mensen eerder subtiel verschil geven — voor anderen nauwelijks. Twijfel je over dosering of medicatie? Vraag het aan je huisarts.

Mijn slaap is 'goed' maar ik word moe wakker — wat dan?

Kijk dan naar **diepe slaap** en hoe gespannen je overdag blijft — niet alleen naar het aantal uren in bed. Vaak helpt eerder opstaan, meer daglicht buiten en minder alcohol meer dan nog een capsule.

Helpt CBD-olie voor slaap?

Het wetenschappelijke beeld is wisselend; kwaliteit van olieën verschilt sterk. Bij de enen voelt het rustgevender, anderen worden er alert van. Het is geen eerste stap in deze gids; neem medicatie en lever altijd mee naar je arts.

Wanneer naar de huisarts met slaapproblemen?

Bij aanhoudende vermoeidheid overdag ondanks voldoende tijd in bed, luid snurken met apneu-vermoeden, onverklaarde pijn, depressieve klachten, of slaapproblemen die je dagfunctioneren ondermijnen: vraag professioneel onderzoek aan.

Wil je weten waar je staat?

Slaap is een van de zes domeinen die we meten in de gratis Leefstijlcheck. In een paar minuten zie je waar je op scoort — en welk profiel bij jou past.

perfectsupplement.nl/intake

Bronnen

- ¹ Wurtman RJ. Age-Related Decreases in Melatonin Secretion—Clinical Consequences. *J Clin Endocrinol Metab.* 2000;85(6):2135–2136. PMID: 10852443
- ² Hardeland R. Melatonin in Aging and Disease—Multiple Consequences of Reduced Secretion, Options and Limits of Treatment. *Aging Dis.* 2012;3(2):194–225. PMC3377831
- ³ Claustrat B, Leston J. Melatonin: Physiological effects in humans. *Neurochirurgie.* 2015;61(2–3):77–84.
- ⁴ Ohayon MM et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals. *Sleep.* 2004;27(7):1255–1273. PMID: 15586779
- ⁵ Leproult R, Van Cauter E. Effect of 1 week of sleep restriction on testosterone levels in young healthy men. *JAMA.* 2011;305(21):2173–2174. PMID: 21632481
- ⁶ Wittert G. The relationship between sleep disorders and testosterone in men. *Asian J Androl.* 2014;16(2):262–265. PMC3955336
- ⁷ Drake C et al. Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. *J Clin Sleep Med.* 2013;9(11):1195–1200. PMC3805807
- ⁸ Chang AM et al. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2015;112(4):1232–1237. PMID: 25535358
- ⁹ Okamoto-Mizuno K, Mizuno K. Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm. *J Physiol Anthropol.* 2012;31(1):14. PMC3427038
- ¹⁰ Blume C et al. Effects of light on human circadian rhythms, sleep and mood. *Somnologie.* 2019;23(3):147–156. PMC6751071
- ¹¹ Schuster J et al. Magnesium Bisglycinate Supplementation in Healthy Adults Reporting Poor Sleep: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. *Nat Sci Sleep.* 2025;17. PMC12412596
- ¹² Rawji A et al. Examining the Effects of Supplemental Magnesium on Self-Reported Anxiety and Sleep Quality: A Systematic Review. *Cureus.* 2024;16(4):e59317. PMC11136869
- ¹³ Bannai M, Kawai N. New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep. *J Pharmacol Sci.* 2012;118(2):145–148. PMID: 22293292
- ¹⁴ Lopresti AL et al. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Medicine.* 2019;98(37):e17186. PMC6979308
- ¹⁵ Chandrasekhar K et al. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. *Indian J Psychol Med.* 2012;34(3):255–262. PMID: 23439798
- ¹⁶ Auld F et al. Evidence for the efficacy of melatonin in the treatment of primary adult sleep disorders. *Sleep Med Rev.* 2017;34:10–22. PMID: 28648359
- ¹⁷ Zhang Y et al. Association of magnesium intake with sleep duration and sleep quality. *PLoS One.* 2022;17(1):e0261989. PMC8782427
- ¹⁸ Carney CE et al. The consensus sleep diary: standardizing prospective self-monitoring. *Sleep.* 2012;35(2):287–302. PMC3250369

Disclaimer

Deze gids is informatief en geen medisch advies. Bij aanhoudende slaapproblemen raden we aan contact op te nemen met je huisarts. Supplementen vervangen geen diagnose of behandeling.

© 2026 PerfectSupplement.nl — Onafhankelijk. Onderbouwd. Voor mannen 40+.